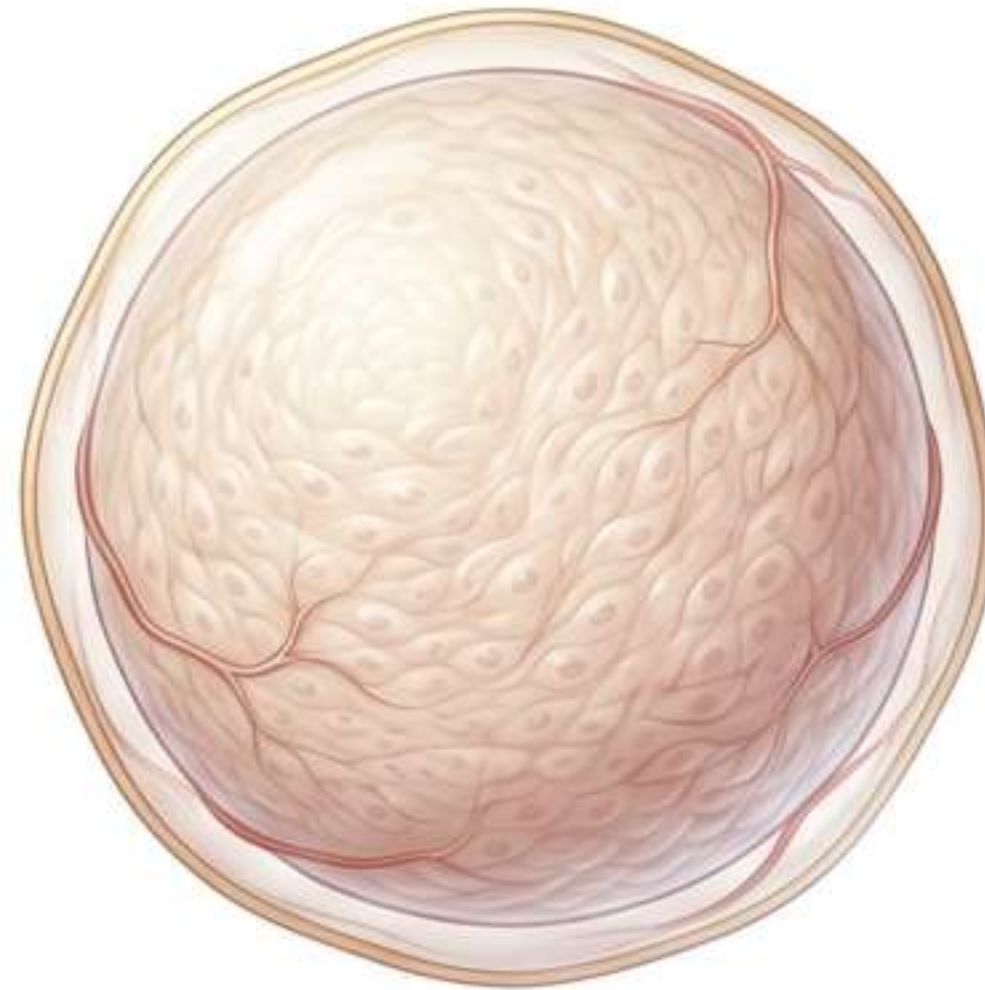


ANATOMIE PATHOLOGIQUE — GUIDE D'ÉTUDE

LES TUMEURS BÉNIGNES

Cours Complet & Analyse des Questions d'Examen



Basé sur le polycopié officiel • Mises à jour 2024

PLAN DU COURS

1. MACROSCOPIE

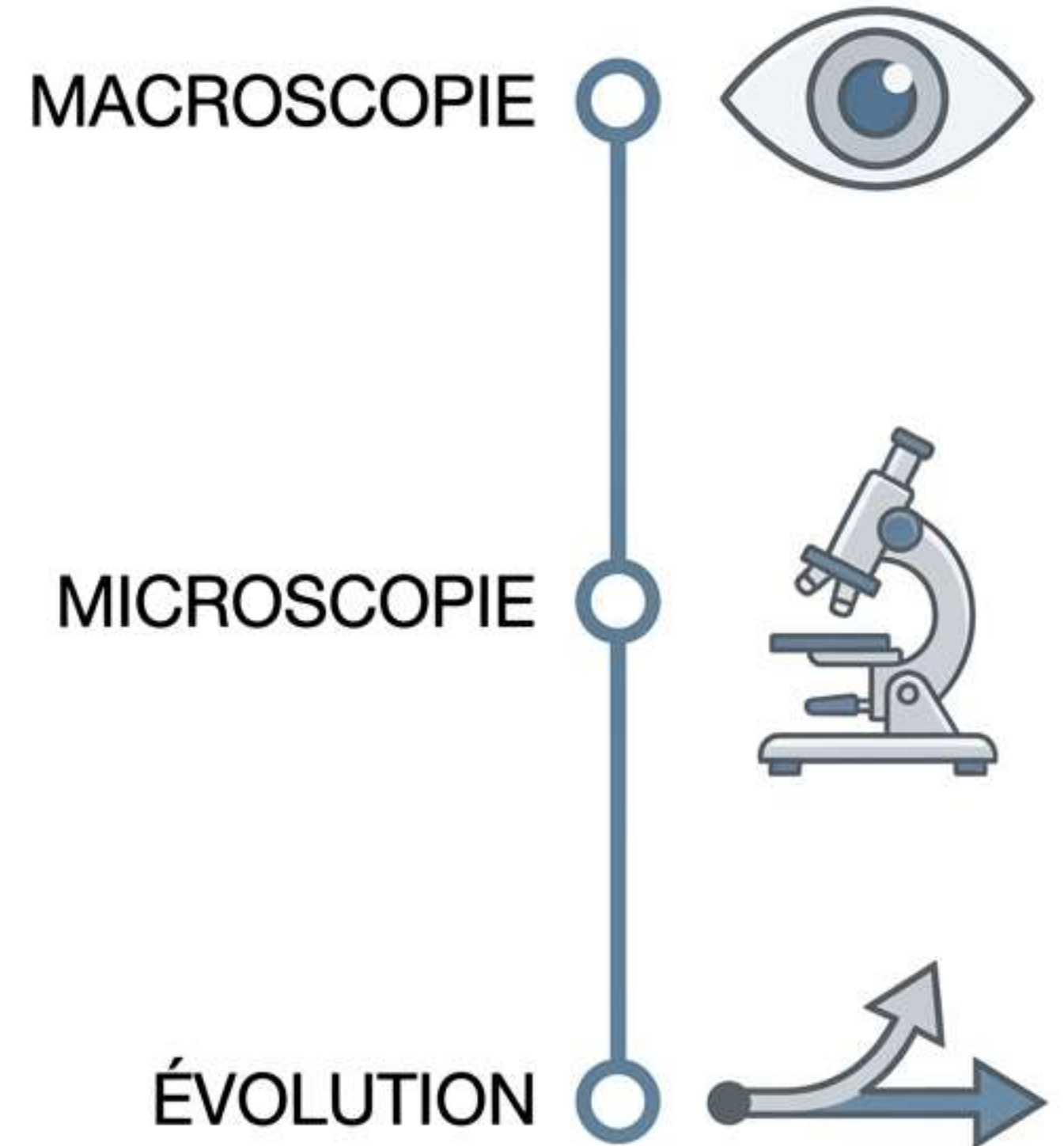
- Taille & Forme
- La Capsule (Tissus profonds)
- Revêtement (Tumeurs de surface)
- Aspect à la coupe (Architecture)

2. MICROSCOPIE

- Prolifération cellulaire
- Les 3 Critères d'Absence (Preuves de bénignité)
- Validation de l'exérèse

3. ÉVOLUTION

- Locale (Compression)
- Générale (Pronostic)



1. MACROSCOPIE : GÉNÉRALITÉS

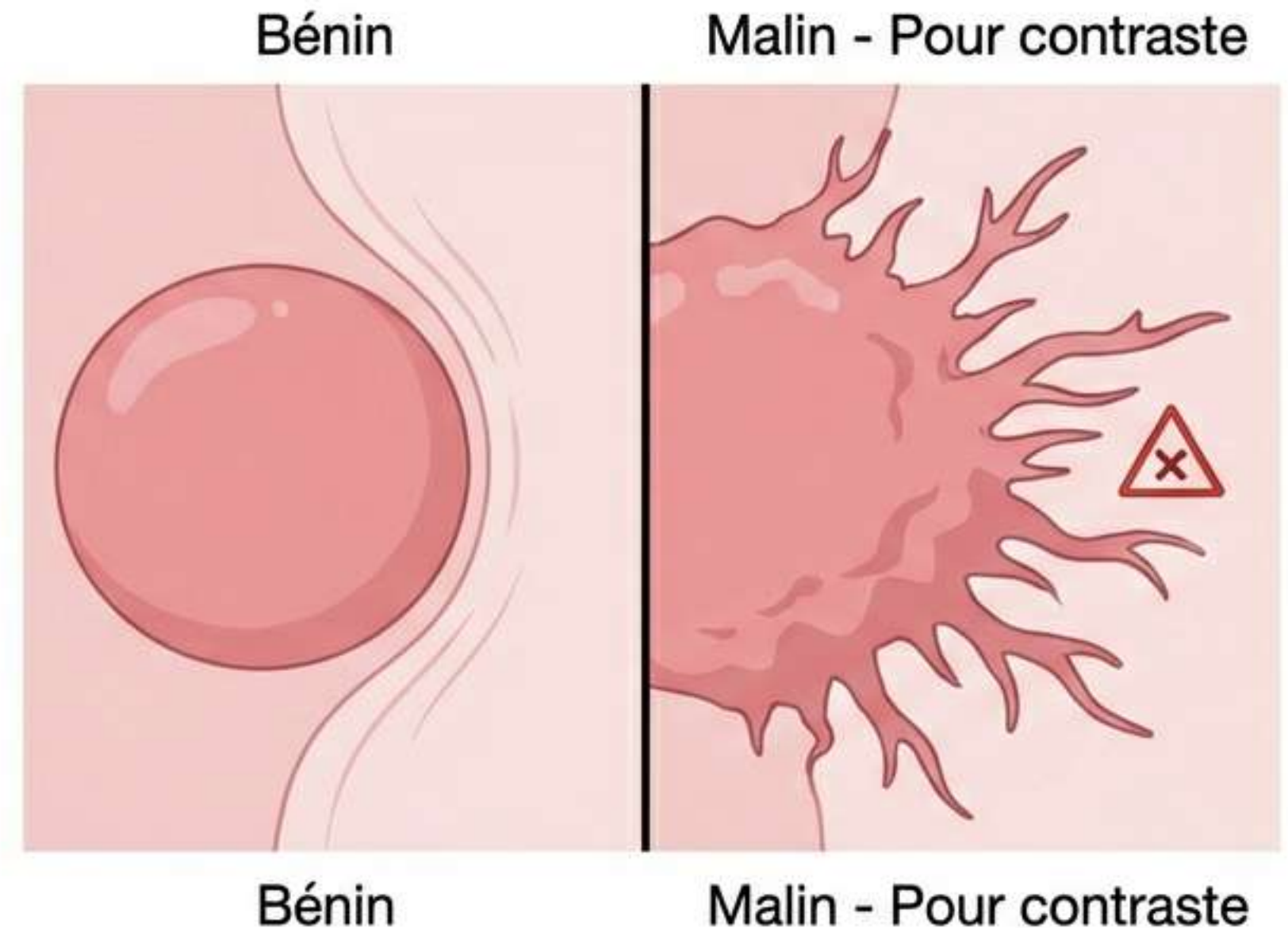
TAILLE

- Extrêmement variable : de quelques millimètres à plusieurs centimètres.

FORME & LIMITES

- Règle absolue : Une tumeur bénigne est bien limitée.
- Elle n'envahit pas les tissus de voisinage [Ref: Q1, Q4].
- Elle repousse les tissus (refoulement) mais ne les infiltre pas.

LIMITES TUMORALES



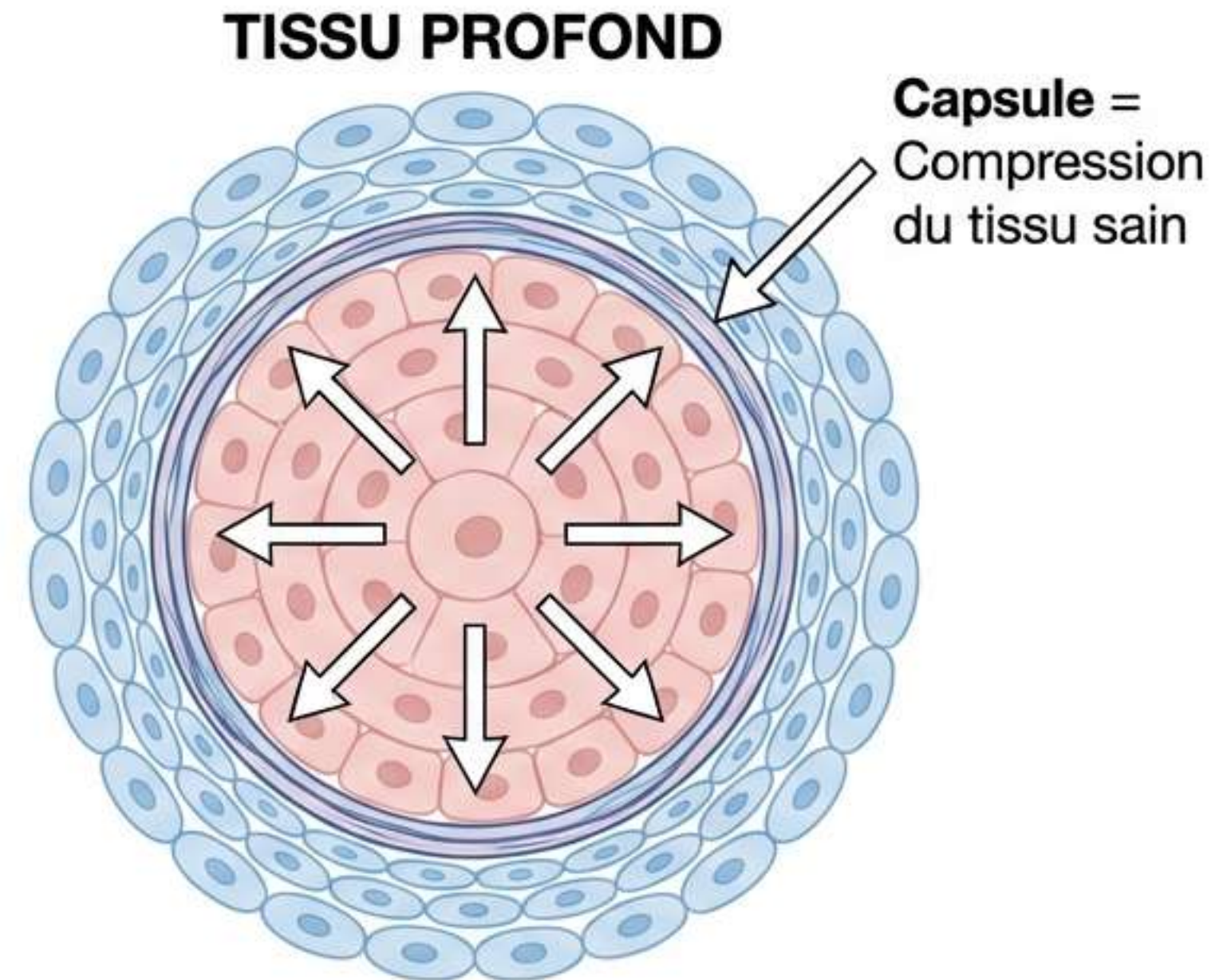
TISSUS PROFONDS : LA CAPSULE

DÉFINITION

- Une tumeur bénigne développée dans un tissu glandulaire est encapsulée, nodulaire et correspond à un adénome [Ref: Q5].

MÉCANISME DE FORMATION

- La capsule est formée par la **compression des tissus normaux** de voisinage due à la croissance expansive de la tumeur.
- **ATTENTION** : Elle ne correspond PAS à une réaction fibro-inflammatoire (contrairement aux abcès ou au kyste hydatique).



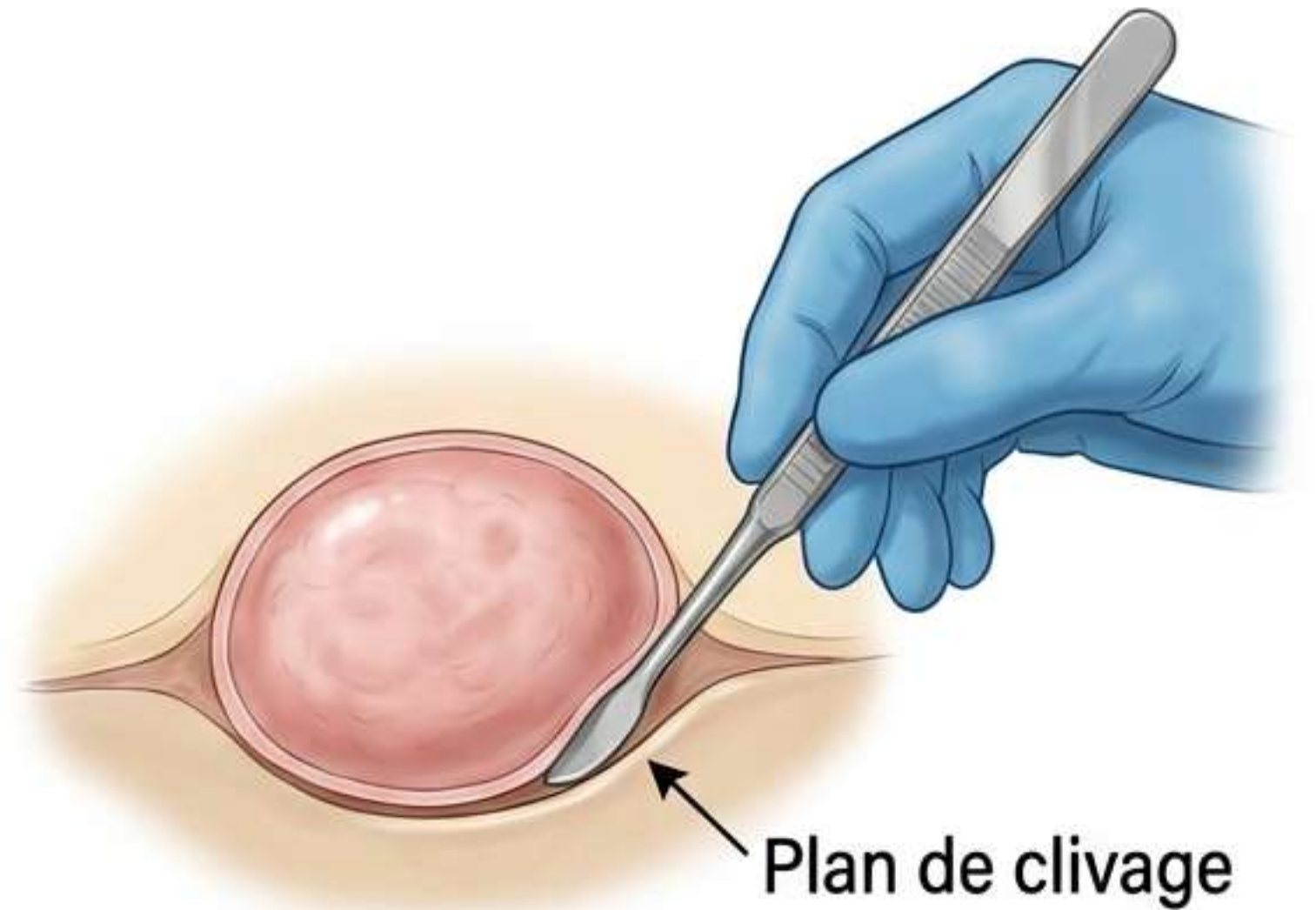
INTÉRÊT CLINIQUE DE LA CAPSULE

CHIRURGIE : LE PLAN DE CLIVAGE

- La capsule constitue un plan de clivage naturel.
- Elle facilite l'**énucléation chirurgicale** (retrait de la tumeur sans emporter le tissu sain).

VALEUR DIAGNOSTIQUE

- L'encapsulation est un signe habituel de bénignité [Ref: Q6].



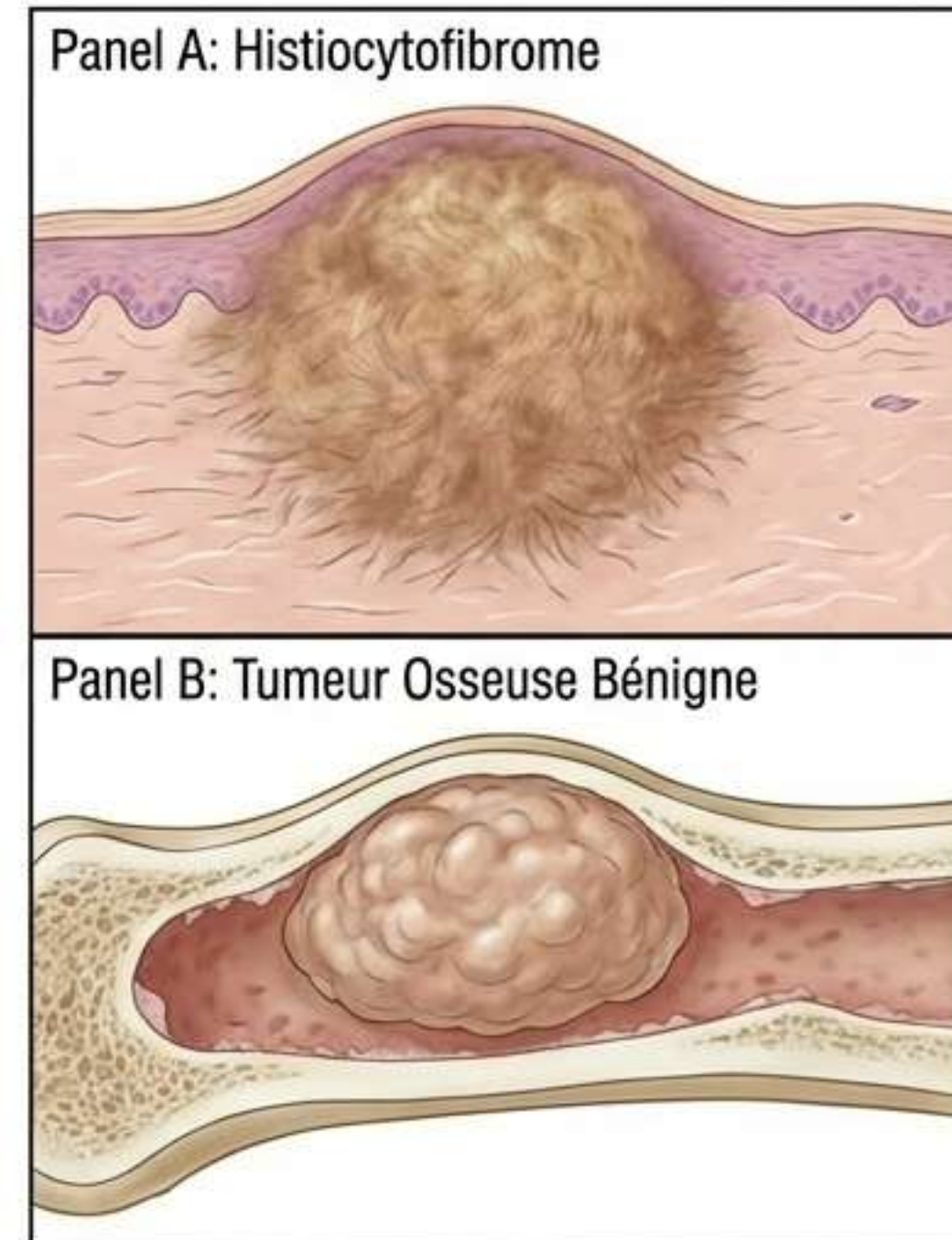
MACROSCOPIE : PIÈGES ET EXCEPTIONS

LES EXCEPTIONS (BÉNIN MAIS NON ENCAPSULÉ)

1. **Histiocytofibrome** (Tumeur dermique) : Elle n'est pas limitée macroscopiquement.
2. **Tumeur osseuse bénigne** : Elle n'est pas encapsulée.
 - MAIS : Elle ne détruit pas la corticale osseuse et n'infiltré pas le périoste.

LE FAUX-AMI (MALIN D'APPARENCE BÉNIGNE)

- Certains cancers à croissance lente semblent encapsulés, mais un examen attentif montre que la capsule est franchie (invasion microscopique ou nodules à distance).



TUMEURS DE REVÊTEMENT (SURFACE)

ASPECT GÉNÉRAL

- Réalise une prolifération **exophytique**.

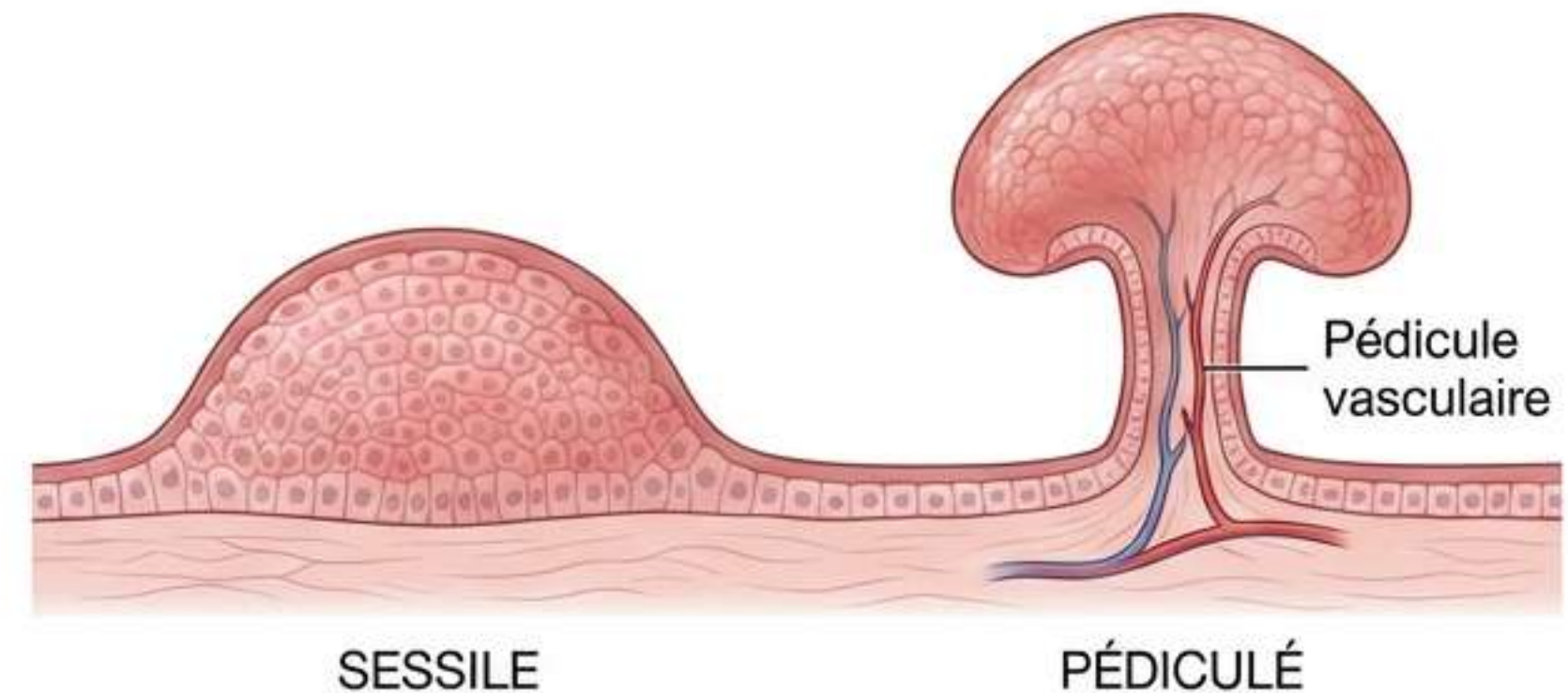
MODES D'IMPLANTATION

- **Sessile** : Étalée en surface, surélevée, large base d'implantation.
- **Pédiculée** : Reliée au tissu originel par un pédicule long, grêle et souple (qui contient les vaisseaux).

L'EXCEPTION DANGEREUSE

- **Carcinome malpighien verruqueux** (Muqueuses buccales).
- Macroscopiquement, il ressemble à un papillome (bénin), mais c'est un cancer.

Types d'implantation



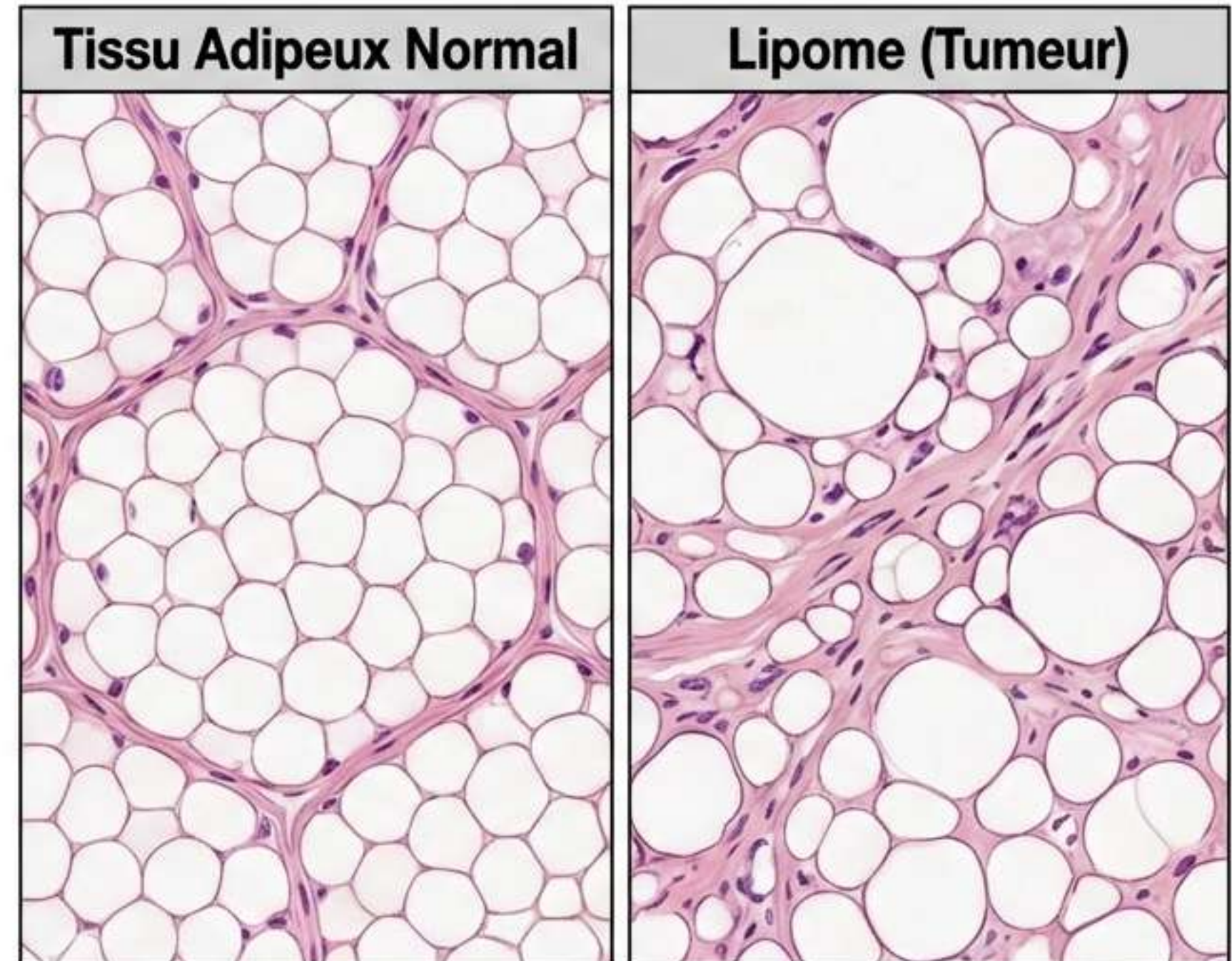
ASPECT À LA COUPE : ARCHITECTURE

LA RESSEMBLANCE

- À l'examen macroscopique, la tumeur ressemble au tissu normal de voisinage [Ref: Q2].
- *Exemples* : Lipome $\approx$ Tissu adipeux ; Chondrome $\approx$ Cartilage.

LA DIFFÉRENCE : L'ANARCHIE ARCHITECTURALE

- Ce qui différencie la tumeur du tissu normal, c'est l'**absence d'organisation**.
- *Exemple* : Le lipome n'est pas formé de lobules réguliers comme le tissu gras normal.



REMANIEMENTS TISSULAIRES

RÈGLE D'OR : LA NÉCROSE

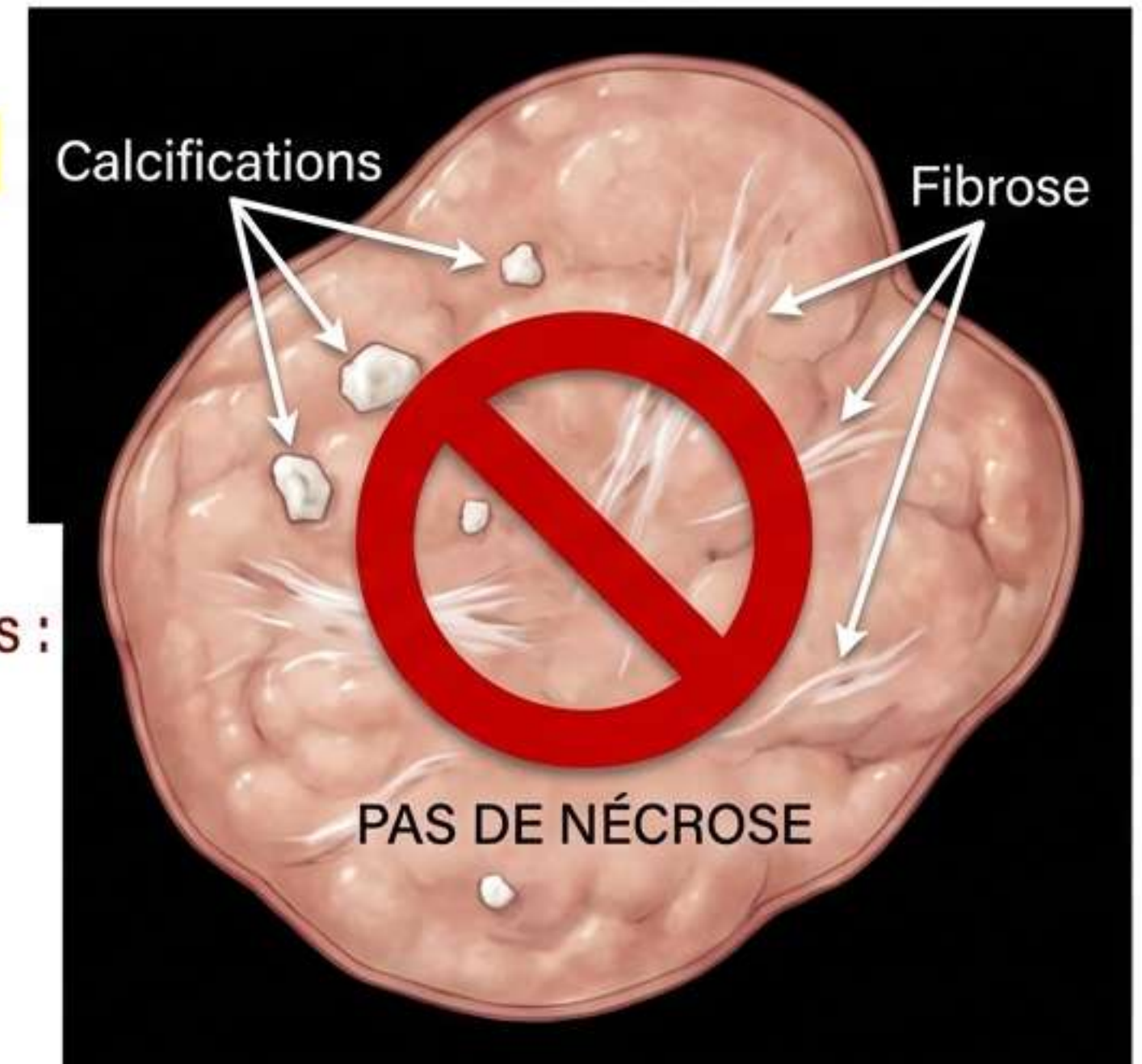
- Une tumeur bénigne ne contient habituellement pas de foyers de nécrose [Ref: Q1, Q9].
- (La nécrose est un signe majeur de malignité).

REMANIEMENTS POSSIBLES

La tumeur peut présenter des modifications secondaires :

- Plages de fibrose.
- Hémorragies.
- Calcifications.

Exemple : Adénome parotidien remanié.



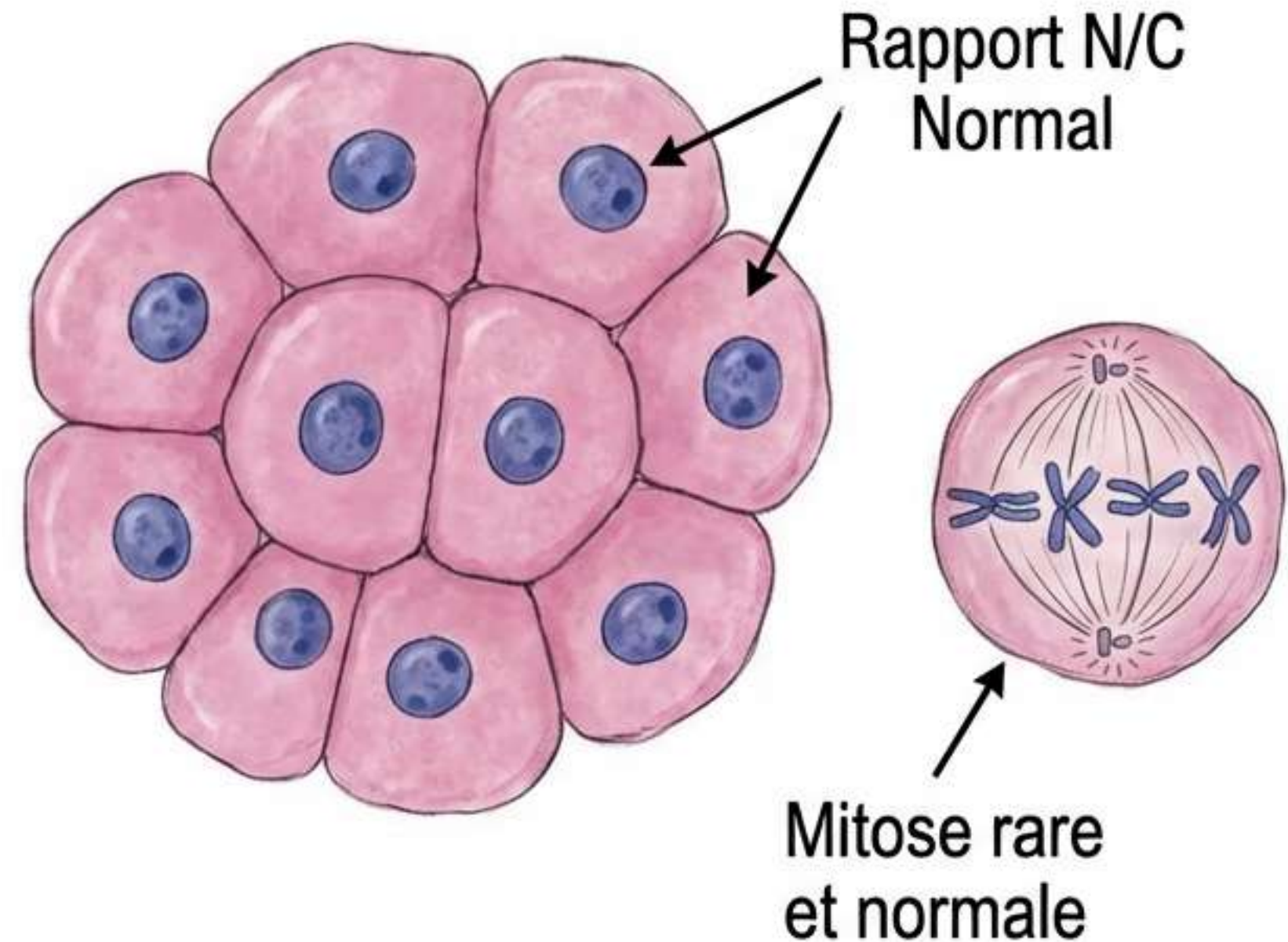
2. MICROSCOPIE : LA CELLULE

IDENTIFICATION

- Les cellules néoplasiques ressemblent aux cellules du tissu d'origine.
- Elles sont facilement identifiées.

CARACTÉRISTIQUES CYTOLOGIQUES

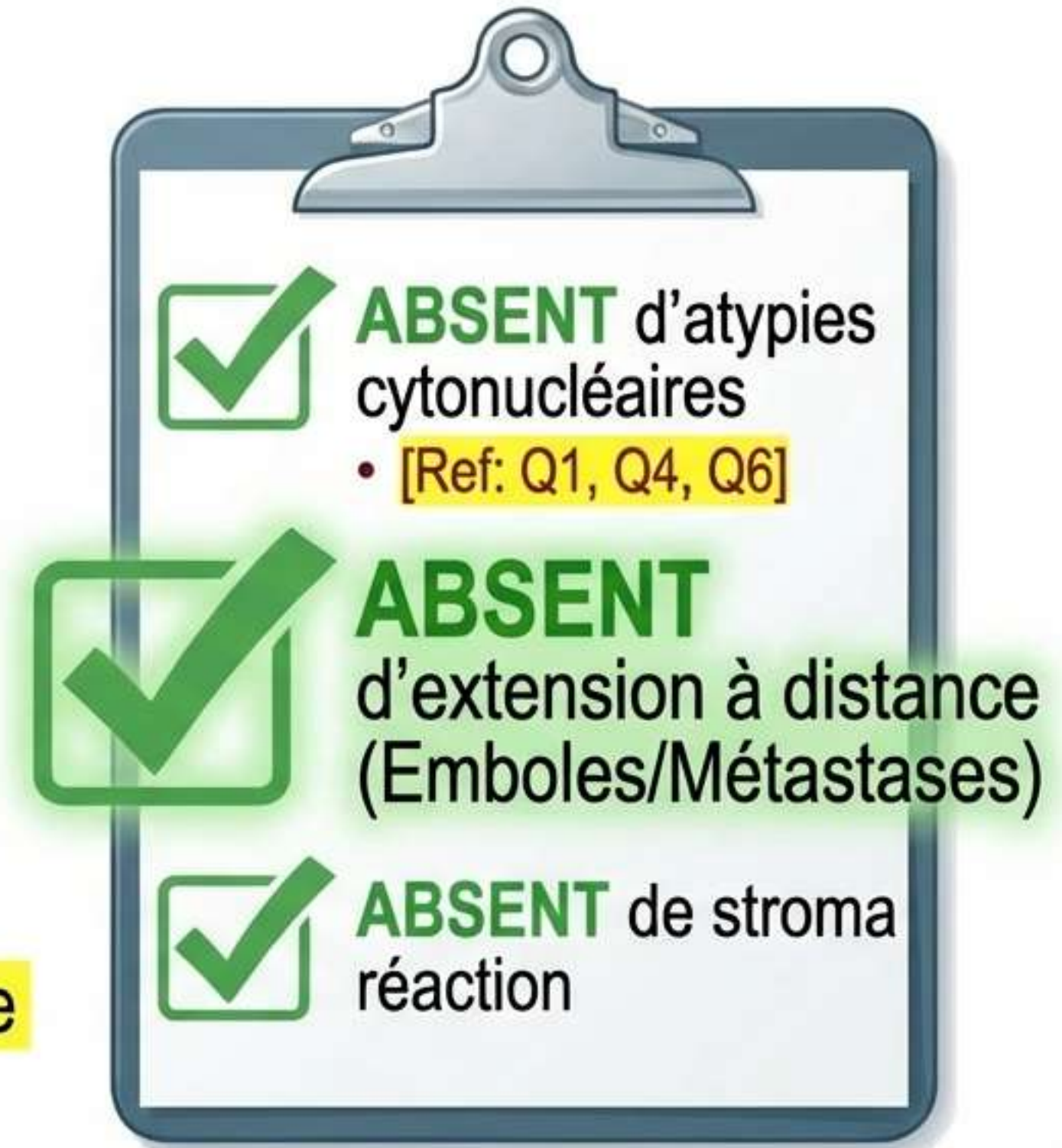
1. **Rapport Nucléo-Cytoplasmique (N/C)** : Il est strictement **NORMAL**.
2. **Mitoses** : Elles sont rares. Si présentes, elles sont **NORMALES**.



LES CRITÈRES D'ABSENCE (PREUVES DE BÉNIGNITÉ)

Le diagnostic de bénignité repose sur l'absence de trois éléments clés :

- La **métastase** est l'élément ABSOLU qui **distingue** la tumeur bénigne de la maligne [Ref: Q1, Q6, Q8].



VALIDATION MICROSCOPIQUE ET LIMITES

ÉTUDE DE LA CAPSULE

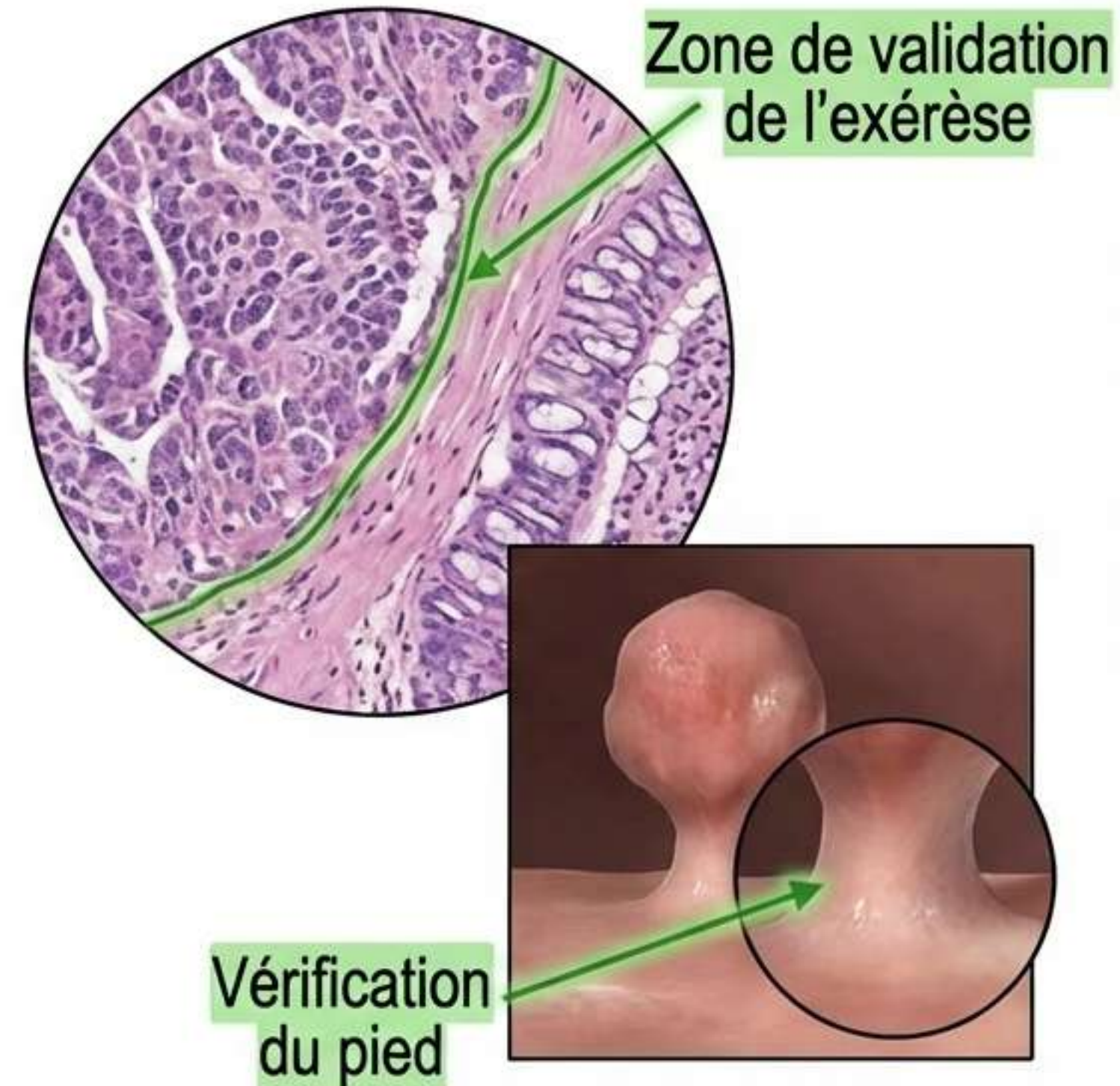
- L'intégrité de la capsule est un signe de bénignité.
- Un diagnostic d'adénome nécessite l'étude de la **TOTALITÉ** de la capsule (tout nodule doit être prélevé en entier).

QUALITÉ DE L'EXÉRÈSE

- L'examen valide que l'opération passe bien en tissu sain.

TUMEURS DE SURFACE

- Il est impératif de vérifier l'absence d'extension de la prolifération dans le **pied** de la tumeur.



3. ÉVOLUTION : COMPORTEMENT LOCAL

ACTION SUR L'ORGANE

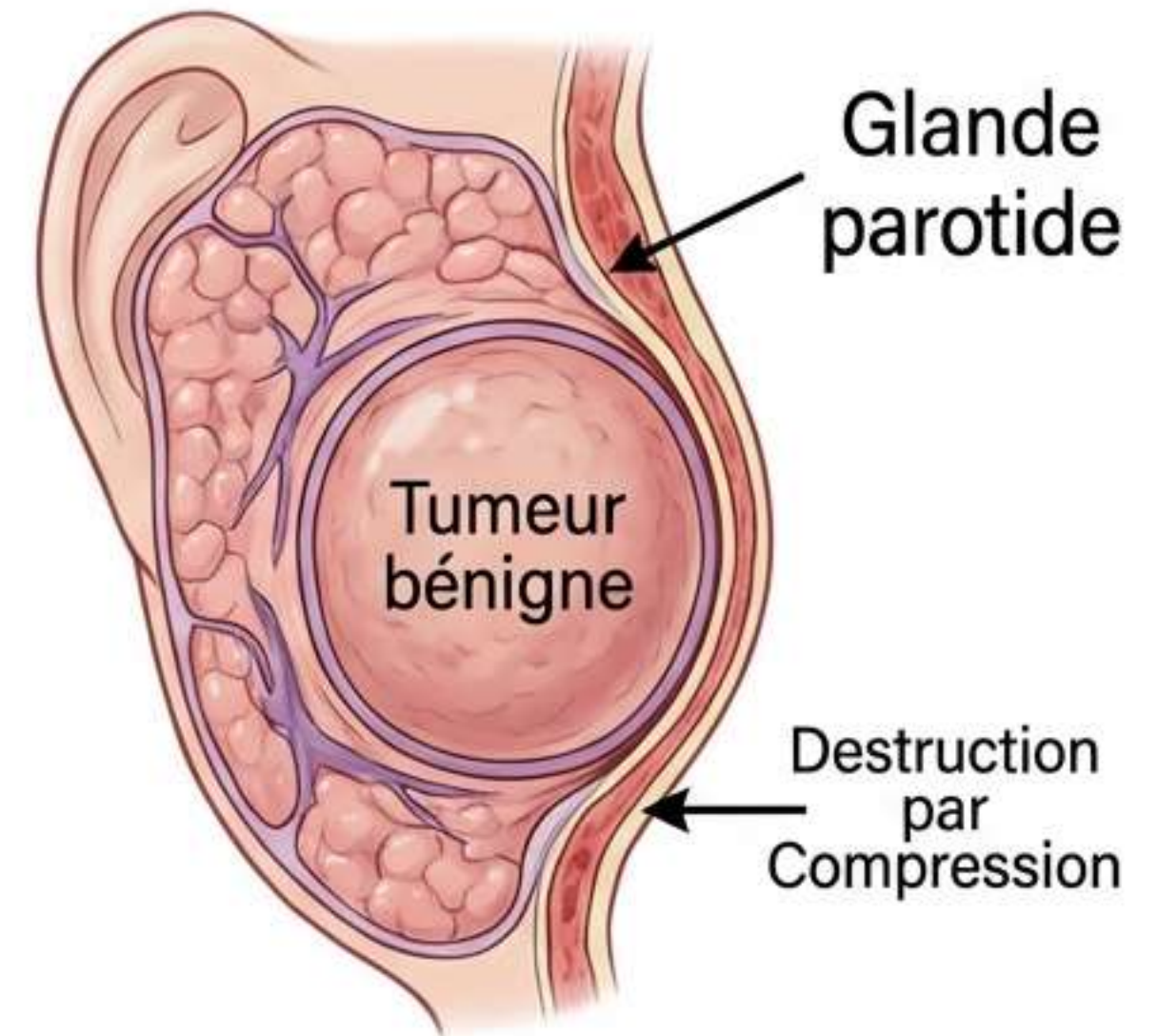
- La tumeur bénigne peut détruire l'organe dans lequel elle se développe.

MÉCANISME DE DESTRUCTION

- Destruction par COMPRESSION (mécanique).
- Elle n'infiltré JAMAIS le tissu voisin [Ref: Q1, Q4].

EXEMPLE

- Un adénome parotidien peut atrophier la glande par simple pression.



RÉCIDIVE ET PRONOSTIC VITAL

RÉCIDIVE

- Le plus souvent : ABSENTE.
- Exception : Récidive possible si l'exérèse est incomplète (tissu tumoral laissé en place) [Ref: Q1].
- Cette récurrence ne signifie pas une aggravation du pronostic.



Location Risk

DANGÉROSITÉ POTENTIELLE

Bien que bénigne (ne tue pas par elle-même), elle peut être grave selon :

1. **Sa localisation** : (ex: adénome hypophysaire comprimant le cerveau).
2. **Ses caractères fonctionnels** : (sécrétion hormonale active).



Functional Risk

SYNTHÈSE EXAMEN : BÉNIN vs MALIN

TUMEUR BÉNIGNE	TUMEUR MALIGNE
LIMITES • Bénin: Bien limitée / Encapsulée [Ref: Q5]	LIMITES • Malin: Mal limitée / Infiltrante [Ref: Q4]
EXTENSION • Bénin: JAMAIS de métastases [Ref: Q1, Q6, Q8]	EXTENSION • Malin: Métastases possibles (Critère absolu) [Ref: Q4, Q6]
CYTOLOGIE • Bénin: Pas d'atypies, mitoses rares/normales [Ref: Q1]	CYTOLOGIE • Malin: Atypies, mitoses nombreuses/anormales
NÉCROSE • Bénin: Habituellement absente [Ref: Q1, Q9]	NÉCROSE • Malin: Fréquente (ex: Sarcomes) [Ref: Q9]

CARTE MENTALE DE RÉVISION (MIND MAP)

